ITH

• GUIA PARA A ENFERMAGEM

Guia de enfermagem

Método Canguru

Com a **virada da OMS** de 2022.

Na UTI Neonatal: **etapas, técnica e evidências**



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC

PARTE 1 · CONCEITO

01

O que é o Método Canguru

Segundo o Ministério da Saúde, é a abordagem mais adequada para cuidar do recém-nascido pré-termo ou de baixo peso, principalmente quando ele precisa de Unidade Neonatal. Não é só colocar o bebê no colo: é uma linha de cuidado que começa no pré-natal, passa pela UTIN e continua em casa, com a Unidade Básica de Saúde.

Por que importa

1

20 milhões

de bebês prematuros ou de baixo peso (menos de 2,5 kg) nascem por ano no mundo. Um terço morre antes de completar um ano.

2

Cerca de 10%

dos bebês no Brasil nascem antes de 37 semanas, cerca de 340 mil por ano, segundo o Cofen.

3

2 a 10 vezes

maior é o risco de morte de prematuros e bebês de baixo peso em relação a bebês a termo com peso normal.

Origem e chegada ao Brasil

1979
Bogotá, Colômbia: surge como alternativa à falta de incubadoras, com a mãe como fonte de calor e alimento.

Anos 1990
Chega ao Brasil e é adaptado: aqui não substitui a tecnologia da UTIN, ele a complementa com cuidado humanizado.

2000
A Portaria nº 693 institui a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso.

2007
A Portaria nº 1.683 atualiza a norma, que hoje integra as diretrizes de cuidado neonatal do SUS.

Os cinco pilares

1. Acolhimento do bebê e da família
2. Respeito às individualidades do RN e dos pais
3. Contato pele a pele o mais precoce possível
4. Envolvimento da mãe e do pai nos cuidados
5. Apoio à amamentação

Como usar este guia

Na primeira vez, leia as partes em ordem. Depois, use o passo a passo da posição canguru (Parte 3), as perguntas frequentes (Parte 7) e a ficha da Parte 8 como consulta rápida no plantão.

PARTE 2 · CUIDADO PROGRESSIVO

02

As três etapas do Método Canguru

O cuidado começa no pré-natal de risco e na UTIN, passa pela Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) e termina no ambulatório, quando o bebê chega a 2.500 g. A passagem de uma etapa para outra depende de critérios do bebê e da família.

Etapa	Onde acontece	O que se faz	Critérios para avançar
1ª etapa	Pré-natal de risco, sala de parto, UTIN e UCINCo	Acesso livre e precoce dos pais; pele a pele assim que houver estabilidade; estímulo à ordenha e à amamentação; pais participando dos cuidados	Estabilidade clínica; nutrição enteral plena (peito, sonda ou copo); peso mínimo de **1.250 g**; mãe disposta a ficar em tempo integral; apoio familiar; consenso entre equipe e família
2ª etapa	UCINCa (enfermaria canguru)	O bebê fica de forma contínua com a mãe, na posição canguru pelo maior tempo possível. Funciona como um "estágio" pré-alta	Mãe segura, motivada e orientada; família consciente dos cuidados em casa; compromisso de manter a posição; peso mínimo de **1.600 g**; ganho de peso adequado nos 3 dias antes da alta
3ª etapa	Ambulatório canguru do hospital de origem + UBS (cuidado compartilhado)	1ª consulta até 48 h após a alta, depois pelo menos uma vez por semana; atendimento garantido no hospital de origem a qualquer momento	Alta da 3ª etapa com **2.500 g** (protocolos de referência também citam 40 semanas de idade corrigida); depois, seguimento de rotina

Atenção na prova e na prática. Medicações orais, intramusculares ou endovenosas intermitentes não impedem a permanência na 2ª etapa. E a 1ª etapa não tem peso mínimo para o contato pele a pele: ele é indicado para todos os recém-nascidos estáveis.

Estrutura de leitos

A Portaria GM/MS nº 930/2012 prevê, para cada **2 leitos de UTIN**, **2 de UCINCo** e **1 de UCINCa**.

Pesos para guardar

Pele a pele: sem peso mínimo. Entrar na 2ª etapa: 1.250 g. Alta hospitalar: 1.600 g. Alta da 3ª etapa: 2.500 g.

PARTE 3 · TÉCNICA

03

Posição canguru passo a passo

O bebê só de fralda, na vertical, em contato pele a pele com o peito da mãe ou do pai, pelo tempo que for bom para os dois: no mínimo 1 hora e, de preferência, 3 horas por colocação. Roteiro baseado nas Diretrizes do Ministério da Saúde e na Estratégia QualiNeo.

Antes de começar

Quem: mãe ou pai (ou quem assume essa função). Não se recomenda por outras pessoas.
Quando: o mais cedo possível, de preferência na 1ª hora de vida; na UTIN, assim que a equipe avaliar estabilidade e prescrever.
Para quem: todos os RN, sem peso ou idade gestacional mínimos.

Não impedem, com sinais vitais estáveis

Ventilação mecânica (inclusive invasiva), cateter umbilical ou outros acessos profundos, drogas vasoativas, nutrição parenteral e extremo baixo peso.
Exceção na sala de parto: instabilidade hemodinâmica ou respiratória que exija reanimação e suporte ventilatório.

1. Converse com os pais, tire dúvidas e respeite diferenças culturais, étnico-raciais e de gênero.
2. Confirme a indicação e separe o material: poltrona confortável e faixa ou top de algodão ou malha.
3. Verifique temperatura, FC, FR e saturação **antes, durante e depois** da transferência. Bebê em ventilação fica monitorizado continuamente.
4. Faça antes os procedimentos previstos: aspiração do tubo, troca de fralda, checagem da fixação de acessos e cânula.
5. Leve a mãe ou o pai ao leito. Não precisa de roupa especial: a mãe retira o sutiã e, se necessário, usa avental hospitalar.
6. Bebê só de fralda. Touca e meias podem ser usadas em ambiente frio; luvas não são recomendadas.
7. Transfira o bebê envolto em coberta aquecida. Com respirador, bomba de infusão ou outros equipamentos, **pelo menos dois profissionais**.
8. Posicione na vertical, contra o peito: cabeça lateralizada, membros fletidos e abduzidos, sem tecido entre as peles. Evite hiperflexão ou hiperextensão do pescoço e abdução exagerada do quadril.
9. Envolva mãe ou pai e bebê com a faixa: o uso é **obrigatório** por segurança.
10. Acomode o responsável na poltrona (na UCINCa, pode ser cama com cabeceira a 45°) e mantenha a observação.

PARTE 4 · TEMPO E EVIDÊNCIAS

04

Quanto tempo e o que muda

1h

Mínimo por colocação

O ideal são 3 horas, para o bebê se reorganizar, relaxar e dormir.

24h

Sem limite máximo

A OMS recomenda de 8 a 24 horas por dia.

5º

Dia de vida

É quando o primeiro contato ainda costuma ocorrer no Brasil. Antecipar é meta de qualidade.

Em centros de referência brasileiros, bebês com menos de 1.800 g que fizeram mais de 3 horas por dia de pele a pele tiveram menor mortalidade.

A principal evidência: 25% menos mortes

Em um grande estudo multicêntrico com bebês de 1.000 a 1.799 g (N Engl J Med, 2021), começar o contato pele a pele logo após o nascimento reduziu em 25% a mortalidade até 28 dias, em comparação ao cuidado convencional. Metanálises anteriores já mostravam queda de cerca de 40% quando o método começava após a estabilização.

Para o bebê

- Melhor controle térmico e menos hipotermia
- Menor risco de infecção hospitalar
- Menos estresse e dor; sono e organização melhores
- Mais ganho de peso, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor (é estratégia de neuroproteção)
- Mais aleitamento e maior produção de leite
- Menor tempo de internação

Para a família e a equipe

- Menos tempo de separação e vínculo mais forte com mãe e pai
- Pais mais confiantes e preparados para cuidar em casa
- Melhor humor materno e relação familiar
- Comunicação melhor entre família e equipe

PARTE 5 · OMS E EQUIPE

05

A virada da OMS e o papel de cada um

Em 15 de novembro de 2022, a OMS publicou novas recomendações para o pré-termo e o bebê de baixo peso. Três mudanças que todo profissional de UTIN precisa conhecer:

1

Rotina para todos

Método canguru para todo pré-termo ou bebê de baixo peso, no hospital ou em casa. Recomendação forte, evidência de alta certeza.

2

Início imediato

Logo após o nascimento, sem período inicial na incubadora, com monitorização. Exceções: não respira após a reanimação, choque ou ventilação mecânica.

3

8 a 24 h por dia

Pelo maior tempo possível, de preferência com a mãe; pai, parceiro ou familiares assumem quando ela não está.

A OMS também recomenda a presença da família 24 horas na unidade intensiva e o bebê preso ao peito com faixa que mantenha a via aérea livre.

Quem	Atribuições principais
Toda a equipe	Indicar e prescrever a posição assim que houver estabilidade; acolher a família; comunicar com clareza e estar disponível para dúvidas
Enfermagem	Preparar ambiente, material e bebê; fazer a transferência (dois profissionais com suporte ventilatório ou infusão); verificar e registrar sinais vitais e temperatura; orientar e treinar os pais até a alta
Neonatologista	Avaliar estabilidade e indicação; definir critérios de passagem entre etapas e de alta; seguimento no ambulatório
Fono, nutrição e banco de leite	Apoiar a ordenha, a transição para via oral e o aleitamento materno
Fisioterapia e TO	Posicionamento, organização postural e desenvolvimento neuropsicomotor
Psicologia e serviço social	Apoio emocional, rede familiar e garantia de direitos (permanência, alimentação, licença)
Gestão da unidade	Garantir poltronas, faixas, espaço, refeições e descanso para os pais; monitorar indicadores

O Ministério da Saúde exige capacitação das equipes que atuam no método. Os pais são parceiros do cuidado, não visitas.

PARTE 6 · IMPLEMENTAÇÃO

06

Família, indicadores e barreiras reais

Pai, família e rede de apoio

- O pai pode e deve fazer a posição canguru
- Presença livre dos pais, 24 h por dia, desde a 1ª etapa
- Internação acima de duas semanas: licença-maternidade contada da alta, não do nascimento (Cofen)
- Avós e irmãos em visitas programadas fortalecem a rede de casa

3 indicadores simples

1. Idade média, em dias, da primeira posição canguru
2. Tempo médio, em horas por dia, de posição canguru
3. Proporção de bebês que fizeram canguru ao menos uma vez na internação

O maior desafio no Brasil é o atraso: o primeiro pele a pele ainda costuma acontecer por volta do 5º dia, enquanto a OMS recomenda logo após o nascimento. A maioria das barreiras é de organização e cultura, não de tecnologia.

Barreira comum	Boa prática
Medo de mobilizar bebês em ventilação ou com cateter	Protocolo escrito de transferência com dois profissionais, checklist de fixações e treino em simulação
Pais ausentes ou com pouca permanência	Acesso livre 24 h, poltronas confortáveis, refeição e descanso para os pais, apoio do serviço social
Sessões curtas, de menos de 1 hora	Combinar períodos de 3 horas ou mais e agrupar procedimentos antes da colocação
Falta de UCINCa ou de ambulatório canguru	Pactuar a 3ª etapa com a UBS e garantir retorno ao hospital de origem
Rotatividade e falta de capacitação	Educação permanente e tutores do método na unidade
Resultados invisíveis	Medir os três indicadores e divulgar para a equipe

PARTE 7 · PERGUNTAS FREQUENTES

07

As dúvidas mais buscadas

As perguntas que mais aparecem no Google sobre o tema, com respostas curtas para consulta no plantão.

O que é o Método Canguru?

Um modelo de atenção humanizada ao RN pré-termo ou de baixo peso e à família, do pré-natal ao seguimento ambulatorial, com o contato pele a pele como eixo. É política pública no Brasil desde 2000.

Para que serve e quais as vantagens?

Reduz mortalidade, infecção e hipotermia; favorece amamentação, ganho de peso, sono e desenvolvimento; diminui a internação e fortalece o vínculo com os pais (Parte 4).

O método tem desvantagens?

Não há desvantagens clínicas quando bem feito, mas há cuidados: via aérea sempre livre, faixa bem ajustada, monitorização e atenção a tubos e cateteres na transferência. Exige preparo da equipe e estrutura para os pais.

Quais são as três etapas?

1ª: pré-natal, UTIN e UCINCo. 2ª: UCINCa, com a mãe em tempo integral. 3ª: ambulatório e UBS após a alta, até 2.500 g (Parte 2).

Qual o peso para cada etapa? Até quantos quilos se faz?

Não há peso mínimo para o pele a pele. Entrada na 2ª etapa: 1.250 g; alta hospitalar: 1.600 g; alta da 3ª etapa: 2.500 g. Depois, a posição pode continuar enquanto for confortável para o bebê e a família.

Bebê intubado pode fazer canguru?

Sim, com sinais vitais estáveis, pelo menos dois profissionais na transferência e monitorização contínua.

Quanto tempo por dia?

No mínimo 1 hora por colocação, idealmente 3 horas. A OMS recomenda de 8 a 24 horas por dia.

O pai pode fazer?

Sim. Pai, parceiro ou outro familiar, especialmente quando a mãe não está disponível.

Onde e quando surgiu?

Em Bogotá, na Colômbia, em 1979. Chegou ao Brasil nos anos 1990; as normas nacionais são as Portarias nº 693/2000 e nº 1.683/2007.

PARTE 8 · NA PRÁTICA

08

Indicadores na mão e ficha da sessão

CÁLCULO RESOLVIDO

Unidade fictícia: os 3 indicadores de um mês

> 10 bebês internados; 8 fizeram posição canguru pelo menos uma vez

> Indicador 3: 8 ÷ 10 = **80% dos bebês** com ao menos uma posição canguru

> Dia de vida da 1ª posição nos 8 bebês: 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 e 8 → soma 40 → 40 ÷ 8 = **5º dia em média**

> Horas de canguru somadas no mês: 360 h em 240 bebês-dia de internação → 360 ÷ 240 = **1,5 h por dia**

Cálculo próprio com dados fictícios. A unidade está no padrão brasileiro de atraso (5º dia) e longe das 8 a 24 h/dia da OMS: as metas são antecipar o primeiro contato e alongar as sessões para 3 h ou mais.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Ficha da sessão de posição canguru

RN / leito		**Data**	
Quem fez (mãe, pai, outro)		**Início e fim**	

Checklist antes	Visto
☐ Indicação prescrita e estabilidade avaliada	
☐ Pais orientados; dúvidas respondidas	
☐ Aspiração, fralda e fixações checadas antes	
☐ Poltrona e faixa ou top prontos	
☐ Dois profissionais (se ventilação ou infusão)	
☐ Faixa ajustada; via aérea livre; cabeça lateralizada	

Sinais vitais	Antes	Durante	Depois
Temperatura axilar			
Frequência cardíaca			
Frequência respiratória			
SpO2			
Duração total			
Intercorrências			

Some as durações do dia no prontuário: é daí que sai o indicador de horas por dia. Indicação, critérios e condutas seguem a prescrição e o protocolo da sua unidade.

FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Fontes consultadas em 09/11/2026. Os resumos, o cálculo com dados fictícios e a ficha foram feitos pela ITH a partir delas. O texto dos manuais e diretrizes não foi reproduzido: consulte os documentos completos.

01 **Ministério da Saúde: Método Canguru (página do programa)**
gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/metodo-canguru

02 **Ministério da Saúde: Atenção humanizada ao recém-nascido, Método Canguru, manual técnico, 3ª ed.**
bvsms.saude.gov.br

03 **Estratégia QualiNeo: Protocolo Posição Canguru precoce e prolongada e cuidados progressivos**
documento institucional de acesso público

04 **Diretrizes de cuidado do Método Canguru (2018), portal público de boas práticas em saúde neonatal**
documento institucional de acesso público

05 **Sociedade Brasileira de Pediatria: Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, Método Canguru**
sbp.com.br

06 **Cofen: Método Canguru, em seus braços, eu me desenvolvo (2025)**
cofen.gov.br

07 **Portarias GM/MS nº 693/2000, nº 1.683/2007 e nº 930/2012**
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis

08 **OPAS/OMS: WHO advises immediate skin to skin care for survival of small and preterm babies (15/11/2022)**
paho.org

09 **OMS: Recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant, 2022**
who.int

10 **WHO Immediate KMC Study Group. Immediate "kangaroo mother care" and survival of infants with low birth weight. N Engl J Med, 2021**
nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2026486

Ressalvas. Critérios de peso, de passagem entre etapas e de alta podem variar conforme o protocolo de cada unidade. Indicação da posição canguru, avaliação de estabilidade e condutas em bebês com suporte ventilatório seguem a prescrição médica e o protocolo institucional.

ITH

PRÓXIMO PASSO

PARA IR ALÉM

Do pele a pele à UTI neonatal

O Método Canguru exige uma equipe segura para mobilizar bebês com tubo, cateter e infusão. A Pós em UTI Neonatal e Pediátrica da ITH treina em simulação realística a ventilação, o PICC e a urgência neopediátrica do dia a dia da UTIN.

Pós-graduação em UTI Neonatal e Pediátrica

- Simulação realística em laboratório
- PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica
- 440h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- Certificado com validade MEC (ITH, conceito 5)

Quero conhecer a pós ↘

mkt.faculdadeith.com.br/lp/uti-neonatal-pediatrica-captura/

Resumo em 30 segundos

25%
menos mortes até 28 dias com pele a pele imediato

1 h
mínima por colocação; ideal de 3 h

8-24 h
por dia: recomendação da OMS desde 2022

2.500 g
peso de alta da 3ª etapa

Material educativo. Conteúdo para profissionais de enfermagem. Não substitui a capacitação oficial do Método Canguru, os protocolos da instituição nem a prescrição médica. © ITH Educação · faculdadeith.com.br